

Nhiễm Trùng Đường Tiết Niệu (UTI)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · UTI là gì, cách điều trị và cách phòng ngừa

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) xảy ra khi vi khuẩn phát triển trong đường tiết niệu. Đa số là nhiễm trùng **bàng quang**, gây nóng rát khi đi tiểu, tiểu gấp và tiểu nhiều lần. Ít gặp hơn là nhiễm trùng lan lên **thận**, nghiêm trọng hơn. Hầu hết UTI khỏi nhanh với kháng sinh phù hợp, và có nhiều cách phòng ngừa tái phát hiệu quả.

Về tình trạng này

Nhiễm trùng bàng quang (**viêm bàng quang**) thường gây ra:

- **Nóng rát hoặc châm chích** khi đi tiểu
- **Tiểu gấp và tiểu nhiều lần** — mỗi lần chỉ đi được ít
- Nước tiểu đục, sẫm màu hoặc có mùi hôi; khó chịu vùng bụng dưới

Nhiễm trùng thận (viêm bể thận) nghiêm trọng hơn, kèm thêm **sốt, ớn lạnh, đau lưng hoặc đau hông và buồn nôn** — cần được chăm sóc kịp thời.

Nguyên nhân

Vi khuẩn (thường từ ruột) xâm nhập qua niệu đạo và phát triển trong bàng quang. Các yếu tố làm tăng nguy cơ gồm **quan hệ tình dục, mãn kinh** (estrogen giảm), không tiểu hết, ống thông, sỏi và bệnh tiểu đường.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

UTI

Nhiễm trùng ở bất kỳ vị trí nào trong đường tiết niệu.

Viêm bàng quang

Nhiễm trùng bàng quang — dạng UTI phổ biến nhất.

Viêm bể thận

Nhiễm trùng thận — nặng hơn, thường kèm sốt.

Cấy nước tiểu

Xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn để chọn đúng kháng sinh.

UTI tái phát

Nhiễm trùng lặp đi lặp lại (thường 2–3 lần trở lên trong một năm).

Estrogen âm đạo

Kem/viên đặt liều thấp giúp giảm nguy cơ UTI sau mãn kinh.

Vi khuẩn niệu không triệu chứng

Có vi khuẩn trong nước tiểu nhưng không có triệu chứng — thường không cần điều trị.

TÔI CÓ LUÔN CẦN KHÁNG SINH KHÔNG? Nếu bạn có triệu chứng, UTI cần được điều trị bằng kháng sinh. Nhưng nếu xét nghiệm nước tiểu phát hiện vi khuẩn mà bạn **không có triệu chứng gì**, thường **không** cần điều trị — lúc này kháng sinh gây hại nhiều hơn lợi. Các trường hợp ngoại lệ quan trọng là phụ nữ mang thai và trước một số thủ thuật tiết niệu.

Chẩn đoán và điều trị

- Nhóm chăm sóc xác nhận UTI dựa trên **triệu chứng** và **xét nghiệm/cấy nước tiểu**.
- Nhiễm trùng bàng quang được điều trị bằng **đợt kháng sinh ngắn**.
- Nhiễm trùng thận** có thể cần kháng sinh mạnh hơn hoặc dài hơn, đôi khi phải nhập viện.
- Uống hết toàn bộ liệu trình, dù bạn cảm thấy khỏe hơn trước đó.

Phòng ngừa tái phát

- Uống đủ nước** và không nhịn tiểu quá lâu.
- Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục; lau từ trước ra sau.
- Sau mãn kinh, **estrogen âm đạo** có thể giúp giảm nguy cơ.
- Hỏi về các lựa chọn không dùng kháng sinh và về kháng sinh dự phòng nếu nhiễm trùng tái phát thường xuyên.

Nên biết thêm

- Cranberry và D-mannose có thể giúp ích cho một số người; bằng chứng còn chưa rõ ràng — có thể thử dùng.
- UTI tái phát nhiều lần đôi khi cần kiểm tra nguyên nhân (tiểu không hết, sỏi tiết niệu).
- Nếu bạn có ống thông, việc có ít vi khuẩn là bình thường — điều trị dựa trên triệu chứng, không chỉ dựa vào kết quả xét nghiệm.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt, ớn lạnh hoặc đau lưng/đau hông** (có thể là nhiễm trùng thận)
- Buồn nôn hoặc nôn, hoặc cảm thấy rất mệt
- Tiểu ra máu** nhìn thấy được, hoặc triệu chứng không cải thiện sau khi dùng kháng sinh
- Bạn đang mang thai và có bất kỳ triệu chứng UTI nào

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Hầu hết UTI là nhiễm trùng bàng quang (nóng rát, tiểu gấp) và khỏi với đợt kháng sinh ngắn; nhiễm trùng thận (sốt, đau hông) nghiêm trọng hơn.
- Vi khuẩn trong nước tiểu **không có triệu chứng** thường không cần điều trị — trừ khi đang mang thai hoặc trước một số thủ thuật.
- Phòng ngừa tái phát bằng cách uống đủ nước, đi tiểu sau quan hệ và (sau mãn kinh) dùng estrogen âm đạo. Tìm kiếm chăm sóc khi có sốt, đau hông hoặc nôn.